



Résumé : RBP HAS/SFAR/AFEF/ACHBPT (septembre 2025) — prise en charge péri-opératoire de la résection hépatique de l'adulte (résections mineures, donneur vivant, tumeurs neuro-endocrines incluses ; pédiatrie, transplantation, hydatidose/abcès hépatiques, indications chirurgicales et traitement interventionnel non-chirurgical exclus). 3 champs — évaluation/optimisation préopératoire, optimisation peropératoire, optimisation postopératoire — 14 questions, 40 recommandations numérotées (accord fort) et 3 absences de recommandation.

G1/G2 = GRADE 1/GRADE 2 (le source imprime ces niveaux SANS signe +/- ; sens repris du verbe de la phrase). **AE** = avis d'experts (balance bénéfices/risques indéterminée, proposition malgré tout). **ABS** = pas de recommandation (données insuffisantes, AUCUNE proposition faite — distinct de AE et d'une recommandation négative). Toutes à accord fort (2 tours de vote). **Écart** : résumé « 39 recommandations » (7 G1+21 G2+11 AE) vs 40 trouvées en décompte direct (7 G1+22 G2+11 AE) — écart d'un G2, disclosed en détail p.1 du script source.

G1 G2 AE ABS

Champ 1 — Évaluation et optimisation préopératoire

1.1 Éléments du bilan préopératoire (hors fonction hépatique)

Réf.	Recommandation	Grade
R1.1.1	Chez les patients opérés de résection hépatique (chirurgie à haut risque), rechercher systématiquement en préopératoire, pour réduire la morbi-mortalité péri-opératoire : anémie, thrombopénie, anomalie de l'hémostase (baisse du TP, hypofibrinogénémie) ; insuffisance rénale ; cholestase (cf R1.3.2) ; dénutrition/risque nutritionnel majeur ; fragilité ; anomalies de la capacité fonctionnelle (bilan cardiovasculaire adapté au risque).	G1

1.2 Stratégies spécifiques d'optimisation préopératoire

Réf.	Recommandation	Grade
R1.2.1	<i>Préhabilitation</i> — réaliser une préhabilitation (cf Annexe 1) chez les patients à haut risque (dénutrition, âge > 65 ans, fragilité, ASA > 2), pour réduire la durée de séjour et le taux de complications péri-opératoires.	G2
R1.2.2	<i>Nutrition préopératoire</i> — instaurer un support nutritionnel (oral ou entéral autant que possible) chez les patients présentant une dénutrition sévère ou un risque nutritionnel majeur, pour diminuer la morbidité péri-opératoire.	G2
R1.2.3	Ne pas administrer d'immunonutrition pour diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire.	G1
R1.2.4	<i>Drainage biliaire préopératoire</i> — chez les patients présentant un ictère obstructif, discuter au cas par cas un drainage biliaire préopératoire pour diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire.	G2

1.3 Réduire le risque d'insuffisance hépatique post-hépectomie (IHPH)

Réf.	Recommandation	Grade
R1.3.1	Identifier en préopératoire les populations les plus à risque d'IHPH afin de limiter sa survenue.	G1
R1.3.2	Utiliser un faisceau de critères ciblés selon le contexte clinique/ressources disponibles (cf Annexe 2) : chez tous les patients — scores clinico-biologiques (ALBI, APRI, ALBI+APRI, Fib4), volumétrie hépatique et/ou biomarqueurs spécifiques ; chez les patients atteints ou suspects d'hépatopathie chronique — score de Child-Pugh et/ou MELD, recherche de signes indirects d'hypertension portale, évaluation de l'hypertension portale (élastométrie ou cathétérisme hépatique si disponible).	G2

Prise en charge péri-opératoire — Résection hépatique

Annexes 1-2 — Préhabilitation et scores clinico-biologiques



Annexe 1 — Éléments d'un programme de préhabilitation multimodale

Axe	Éléments
Exercice physique	Renforcement musculaire ; travail flexibilité/équilibre ; entraînement supervisé (≥ 3×/semaine) ; exercice aérobie d'intensité modérée (marche, jogging, cyclisme).
Intervention nutritionnelle	Évaluation/adaptation des apports caloriques ; optimisation de l'apport protéique (1,5 g/kg/j) ; supplémentation en protéines de lactosérum (whey) ; apport en vitamines et micronutriments.
Prise en charge psychologique	Exercices de réduction d'anxiété et de respiration ; visualisation mentale ; stimulation cognitive et concentration.
Optimisation médicale	Correction de l'anémie ; contrôle glycémique ; arrêt du tabac et de l'alcool.

Annexe 2 — Scores clinico-biologiques (risque d'IHPH)

Score	Formule
MELD	$3,78 \times \ln(\text{bilirubine [mg/dl]}) + 11,2 \times \ln(\text{INR}) + 9,57 \times \ln(\text{créatinine [mg/dl]}) + 6,43$
Fib4	$(\text{Âge} \times \text{ASAT [UI/l]}) / (\text{Plaquettes [10}^9\text{/l]} \times \sqrt{\text{ALAT [UI/l]}})$
APRI	$(\text{ASAT} \times 100) / \text{plaquettes (10}^9\text{/l)}$ — ASAT exprimé en multiple de la limite supérieure de la normale
ALBI	$(\log_{10} \text{bilirubine [}\mu\text{mol/l]} \times 0,66) + (\text{albumine [g/l]} \times -0,085)$
Volume critique du foie futur restant (FFR)	$\text{FFR} / \text{VTH (volume total hépatique)} ; \text{FFR} / \text{poids corporel}$



Champ 2 — Optimisation peropératoire (1/2)

2.1 Choix de l'agent anesthésique

Réf.	Recommandation	Grade
R2.1.1	Ne pas privilégier une modalité d'anesthésie générale (IV vs inhalée) dans le but de réduire la morbidité postopératoire ou d'améliorer la survie globale (dont récurrence carcinologique), quelle que soit l'indication.	G2

2.2 Stratégie de préconditionnement hépatique

Réf.	Recommandation	Grade
R2.2.1	Administrer en peropératoire un bolus de 8-10 mg de dexaméthasone, pour réduire la morbidité postopératoire.	G2
R2.2.2	Ne pas administrer de N-acétylcystéine pour réduire la morbi-mortalité postopératoire.	G2
R2.2.3	Ne pas pratiquer de manœuvres de préconditionnement au sévoflurane ou ischémique (directes ou indirectes) pour réduire la morbidité postopératoire.	G2

2.3 Choix de l'antibioprophylaxie

Réf.	Recommandation	Grade
R2.3.1	Administrer une antibioprophylaxie en respectant les molécules et modalités des recommandations les plus récentes (RFE SFAR/SPILF « Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle », 2024 — déjà git-trackée dans ce corpus), pour prévenir les infections du site opératoire.	AE
R2.3.2	En cas de résection hépatique associée à une chirurgie des voies biliaires : adapter l'antibioprophylaxie aux antécédents infectieux biliaires ; utiliser la pipéracilline-tazobactam chez un patient à risque de colonisation biliaire (drainage percutané/endoprothèse biliaire récents) sans antécédent de bilicuture positive ni de BMR identifiée.	AE

2.4 Optimisation hémodynamique peropératoire

Réf.	Recommandation	Grade
R2.4.1	Utiliser un monitoring du volume d'éjection systolique (VES) associé aux indices dynamiques, pour optimiser l'expansion volémique et diminuer la morbidité péri-opératoire.	G2
R2.4.2	Pour réduire le saignement peropératoire : maintenir une précharge-dépendance par hypovolémie permissive (VVE élevée et/ou PVC basse) jusqu'à la fin de la transsection hépatique, sous couvert d'une pression de perfusion tissulaire adéquate ; restaurer une volémie efficace une fois la transsection terminée.	G2
R2.4.3	Ne pas monitorer systématiquement la PVC pour diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire.	AE
R2.4.4	Ne pas recourir à des traitements (furosémide, nitroglycérine, milrinone) dans le seul but d'obtenir une PVC basse.	AE
R2.4.5	Utiliser des solutés cristalloïdes balancés pour l'expansion volémique peropératoire.	G2
—	Absence de recommandation concernant l'administration d'albumine pour l'expansion volémique peropératoire.	ABS

Annexe 4 (synthèse) : l'algorithme SFAR proposé opérationnalise R2.4.2 en 2 phases — *transsection* (hypovolémie permissive : 12 % < VVE < 20 %, PVC < 5 mmHg si disponible, PAM > 65 mmHg [> 70 mmHg ou > 90 % de la valeur habituelle si hypertendu] ; surveillance des signes d'hypoperfusion — lactates > 3 mmol/l, hausse des vasopresseurs, VVE > 20 % ou baisse du VES) puis *post-résection* (restauration de la volémie guidée par le VES : bolus de 250 ml, poursuite si hausse du VES ou de la VVE ≥ 10 %, arrêt sinon).



Champ 2 — Optimisation peropératoire (2/2)

Réf.	Recommandation	Grade
R2.5.1	Pour diminuer les complications pulmonaires postopératoires sans surrisque hémorragique peropératoire, appliquer une ventilation protectrice associant : volume courant 6-8 ml/kg de poids prédit ; individualisation de la PEP (≥ 5 cmH ₂ O) pour maximiser la compliance pulmonaire ; manœuvres de recrutement prudentes sous réserve d'une bonne tolérance hémodynamique.	G2

Réf.	Recommandation	Grade
R2.6.1	Ne pas administrer systématiquement d'acide tranexamique de manière préventive en peropératoire, pour diminuer le saignement et la transfusion érythrocytaire.	G2
R2.6.2	En l'absence d'administration préemptive d'acide tranexamique, administrer précocement 1 g d'acide tranexamique ($\pm 2^e$ dose de 1 g) en cas de saignement significatif peropératoire.	AE
R2.6.3	Récupérer le sang épanché en peropératoire (résection carcinologique incluse) et, après évaluation bénéfice-risque, envisager sa réinjection pour diminuer la transfusion érythrocytaire péri-opératoire.	G2

Réf.	Recommandation	Grade
R2.7.1	Sur foie sain (laparoscopie ou laparotomie), recourir à une analgésie multimodale associant paracétamol, AINS et opioïdes (sauf contre-indication), pour diminuer la morbidité postopératoire.	G1
R2.7.2	En cas de risque ou d'altération manifeste des fonctions hépatique/rénale, réévaluer l'indication et/ou la posologie des traitements médicamenteux.	AE
R2.7.3	Par laparoscopie, compléter l'analgésie systémique par une infiltration d'anesthésiques locaux ou un bloc locorégional échoguidé.	G2
R2.7.4	Par laparotomie, compléter l'analgésie systémique par une infiltration d'anesthésiques locaux en continu, un bloc locorégional échoguidé ou une anesthésie péridurale (sauf contre-indication).	G2
R2.7.5	Privilégier l'analgésie péridurale (APD) en cas d'hépatectomie mineure par laparotomie, chez des patients sans cirrhose préopératoire et avec INR/plaquettes normaux — en dehors de ce cadre, risque accru d'hématome épidural rendant l'APD plus à risque.	AE
—	Absence de recommandation, sur foie sain postopératoire, concernant la kétamine, le néfopam ou la lidocaïne intraveineuse pour diminuer la douleur postopératoire.	ABS

Figure 2 (synthèse) : l'algorithme SFAR distingue laparoscopie (infiltration $\pm$ cathéter, ou bloc périphérique $\pm$ cathéter) et laparotomie — hépatectomie mineure sur foie sain ou majeure (infiltration $\pm$ cathéter, bloc périphérique $\pm$ cathéter, ou péridurale) vs hépatectomie mineure sur foie cirrhotique (« pas de recommandation », en pointillés) ; réévaluation clinicien requise en cas d'altération rénale/hépatique préopératoire.



Champ 3 — Optimisation postopératoire (1/2)

3.1 Critères d'admission en unité de soins critiques

Réf.	Recommandation	Grade
R3.1.1	Ne pas admettre systématiquement les patients en unités de soins critiques ; individualiser la décision selon les facteurs de risque liés au patient, à la chirurgie et à l'organisation locale.	G2
R3.1.2	Décider de l'admission en s'appuyant sur l'arbre décisionnel proposé (cf Figure 3), comme outil d'aide à la réflexion clinique.	AE

3.2 Gestion liée à une insuffisance hépatique

Réf.	Recommandation	Grade
R3.2.1	Réaliser une surveillance clinique (ascite, encéphalopathie, défaillances d'organes) et biologique (bilirubine totale, TP, INR, facteur V) régulière et rapprochée, pour dépister précocement une insuffisance hépatique.	G1
R3.2.2	Chez les patients présentant une IHPH, rechercher systématiquement une infection et une complication vasculaire (cinétique des transaminases, scanner injecté et/ou écho-doppler hépatique).	AE
R3.2.3	Ne pas utiliser la N-acétylcystéine pour prévenir ou traiter une IHPH.	G2
—	Absence de recommandation sur l'utilisation de traitements spécifiques (glucocorticoïdes, terlipressine, somatostatine...) pour prévenir l'IHPH.	ABS
R3.2.4	Solliciter un avis auprès d'un centre expert chez tout patient présentant une IHPH, pour évaluer l'intérêt d'une suppléance ou d'une transplantation hépatique.	AE



Champ 3 — Optimisation postopératoire (2/2)

3.3 Prévention du risque thromboembolique

Réf.	Recommandation	Grade
R3.3.1	Résection carcinologique sans cirrhose : prescrire une thromboprophylaxie par HBPM pour une durée de 4 semaines, y compris en chirurgie mini-invasive ou parcours de réhabilitation améliorée.	G1
R3.3.2	Résection carcinologique avec cirrhose : prescrire une thromboprophylaxie par HBPM ; ne pas considérer une thrombopénie modérée et/ou un TP abaissé comme une contre-indication absolue.	AE
R3.3.3	Tumeur bénigne ou donneur vivant : prescrire une thromboprophylaxie par HBPM pour une durée minimale de 7 jours.	G2
R3.3.4	En cas de très haut risque thromboembolique (résection carcinologique + facteur(s) de risque patient), associer une compression pneumatique intermittente per- et postopératoire à la thromboprophylaxie pharmacologique.	G2

3.4 Mesures postopératoires précoces

Réf.	Recommandation	Grade
R3.4.1	Instaurer un programme de réhabilitation améliorée après chirurgie : mobilisation précoce ; réintroduction précoce de la nutrition orale ; support nutritionnel (entéral en 1 ^{re} intention) si apports oraux impossibles/insuffisants (< 50 % des besoins) > 5-7 jours ; contrôle glycémique (éviter > 180 mg/dl soit 10 mmol/l) ; réévaluation quotidienne des drainages avec l'équipe chirurgicale.	G1
R3.4.2	Ne pas appliquer systématiquement une VNI prophylactique ou des séances de CPAP — y compris chez les patients à haut risque — pour prévenir les complications respiratoires postopératoires.	G2
R3.4.3	En cas d'insuffisance respiratoire aiguë postopératoire, appliquer un support respiratoire non invasif (VNI, CPAP, oxygénothérapie haut débit) après avoir vérifié l'absence de nécessité de reprise chirurgicale.	G2

Figure 3 — Arbre décisionnel d'admission en soins critiques (USCr)

Étape	Critères / orientation
Étape 1 (préopératoire)	Risque de décompensation post-opératoire d'une comorbidité, OU hypertension portale (1 critère suffit : varices œsophagiennes ; splénomégalie + plaquettes < 150 G/l ; élasticité ≥ 25 kPa) → si oui : USIP.
Étape 2 (postopératoire)	Complication avec défaillance(s) d'organe → si oui : réanimation.
Étape 3 (complexité de la résection)	Bas grade (métastasectomie, mono-segmentectomie) ou grade intermédiaire (hépatectomie gauche, segmentectomies antéro-latérales, reconstruction biliaire) → étape suivante ; grade élevé (hépatectomie droite/centrale étendue ou non, segmentectomie postérieure complexe dont segment I ; sauf si coelioscopie) → USIP directement.
Étape 4	Hépatopathie chronique significative, OU pertes sanguines importantes/polytransfusion, OU ASA > 3 → si oui : USIP/réanimation ; sinon → SSPI.
Étape 5 (SSPI)	Lactatémie > 3 mmol/l → surveillance prolongée en SSPI (correction volémique/métabolique/transfusion) puis USIP si persistance > 3 mmol/l, sinon service de chirurgie ; lactatémie ≤ 3 mmol/l d'emblée → service de chirurgie.

USCr = unités de soins critiques (USIP = unité de soins intensifs polyvalents, ou réanimation). Scores utilisables pour l'hépatopathie chronique : Child-Pugh B, MELD > 9, liver stiffness > 8 kPa (si cirrhose/carcinome hépatocellulaire), score ABRI (isolé ou associé à l'APRI).



Méthode, sources et avertissement

Champ d'application : résections hépatiques (résections mineures, donneur vivant, tumeurs neuro-endocrines incluses). **Explicitement exclus par le texte source** : pédiatrie, transplantation hépatique, hydatidose et abcès hépatiques, indications chirurgicales, traitement interventionnel non-chirurgical.

Méthode : groupe d'experts SFAR, avec experts AFEF (Société Française d'Hépatologie) et ACHBPT intégrés pour les questions requérant leur expertise. Recherche bibliographique 2004-2024 (méthodologie PRISMA), questions formulées en format PICO. Méthode GRADE : niveau de preuve élevé → recommandation forte (1) ; niveau de preuve faible → recommandation faible (2) ; balance bénéfices/risques indéterminée → avis d'experts (AE) ; absence d'études/résultats concluants → pas de recommandation (ABS). 2 tours de vote, accord fort pour les 40 recommandations retenues.

Document source : HAS, « Prise en charge péri-opératoire du patient adulte lors d'une résection hépatique », recommandation de bonne pratique, adoptée par le Collège de la HAS le 11 septembre 2025. Élaborée par la SFAR avec l'AFEF et l'ACHBPT.

URL source : <https://sfar.org/prise-en-charge-peri-operatoire-du-patient-adulte-lors-dune-resection-hepatique/>

Couverture : intégralité des 40 recommandations numérotées et des 3 absences de recommandation (3 champs, 14 questions), de l'Annexe 1 (préhabilitation), de l'Annexe 2 (scores), et d'une synthèse de l'Annexe 4 et des Figures 2 et 3 (algorithmes/arbre décisionnel, retranscrits depuis un rendu visuel à 180dpi, sans couche texte exploitable). L'Annexe 3 relative à l'antibioprophylaxie (p.18 du source — doublonnant le numéro d'une autre Annexe 3 p.13, non résolu) renvoie à la RFE SFAR/SPILF 2024 déjà git-trackée sous la clé antibioprophylaxie. Bibliographie et composition nominative des groupes de travail non reproduites — non actionnables cliniquement.

Avvertissement : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement les 40 recommandations et les 3 absences de recommandation du texte source (dont le léger écart de décompte avec le résumé de la synthèse, disclosed ci-dessus), mais condense l'argumentaire de chaque item. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la HAS ni la SFAR.